SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

提肛的“暴力美学”：收紧肛门括约肌与减少痔病损伤间的必要联系

丹[1]，宁[2]
在此填写作者的单位信息和资助信息
[1]LY 研究院，L 城，Z 国
[2]LY 研究院，L 城，Z 国
通讯作者：宁（ning******@163.com）
本研究由 ningningning 基金资助（项目编号：Ning*****）

ABSTRACT / 摘要 本文围绕“提肛训练是否必然减轻痔病损伤”这一常见健康命题展开理论分析。基于盆底功能训练原理、痔病保守管理的一般机制以及相关健康传播语境，文章指出：提肛训练作为一种以盆底肌群和肛门周围肌群收缩—放松为核心的功能性训练，确可在一定条件下通过改善局部控制、减少无效努挣和降低持续性局部高压，对痔病症状缓解产生辅助作用；但这种作用主要是间接的、条件性的，并不构成减少痔病损伤的必要条件。进一步分析表明，大众传播中将提肛塑造为一种依靠强力收紧即可防治痔病的“暴力美学”式身体叙事，存在将功能训练绝对化、简化化的倾向。文章认为，提肛训练应被置于“排便习惯重建—盆底功能调节—局部压力管理”的综合框架中理解，其合理定位是辅助性行为干预，而非脱离基础生活方式管理的核心疗法。
INDEX TERMS / 关键词 提肛；暴力美学；肛门括约肌；盆底肌训练；痔病；排便力学；健康传播

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文的主要发现是：提肛训练可通过改善盆底肌群的收缩—放松协调、减少排便时的无效用力及降低局部持续高压，对痔病症状缓解产生一定辅助作用；但这种作用是间接的、条件性的，并不构成减少痔病损伤的必要条件。研究进一步表明，痔病保守管理的核心仍在于纠正便秘、增加膳食纤维和液体摄入、避免排便过度用力以及缩短如厕时间。本文的意义在于纠正公众对提肛训练“绝对化”“万能化”的认知偏差，为痔病的科学自我管理提供更审慎的解释框架。

1. INTRODUCTION / 引言

提肛训练作为一种简便、隐蔽且易于执行的身体训练方式，在日常健康传播中长期被赋予“预防痔疮”“缓解肛门不适”“增强控制力”等多重意义。由于其动作形式具有明显的收紧、控制和自我规训色彩，这一训练在大众叙事中往往被塑造成一种带有强力感和对抗性的身体实践，甚至形成某种近似“暴力美学”的修辞表达：仿佛只要更有力地收紧括约肌，就能更有效地抵御痔病损伤。然而，这种表述虽然具有传播张力，却容易模糊医学意义上的功能训练与经验化想象之间的界限。

从临床常识和病理机制来看，痔病并非单纯由“括约肌不够紧”导致，其发生和加重更常与便秘、排便过度用力、久坐久蹲、如厕时间过长及局部支持结构负担增加等因素相关。这意味着，若将提肛训练简单理解为通过增强局部收缩力即可直接防治痔病，既可能弱化对真正危险因素的关注，也可能将功能性训练误读为局部对抗性刺激。

现有关于提肛训练的讨论，大多停留在经验性建议层面，而较少从身体叙事与功能机制相结合的视角，对其作用边界进行系统阐释。基于此，本文拟在盆底功能调节与排便力学的框架下，分析提肛训练与痔病损伤减轻之间究竟存在何种联系，并进一步讨论“必要联系”这一命题在医学逻辑上是否成立。文章旨在说明：提肛训练并非毫无意义，但其意义更可能体现在辅助性、间接性和行为调节层面，而非构成痔病缓解的充分必要条件。

图 1：收紧肛门括约肌与减少痔病损伤间的必要联系

2. Results / 结果

2.1 提肛训练对痔病可能存在间接的辅助性作用

本文分析认为，提肛训练的潜在积极意义，首先来自其对盆底肌群和肛门周围肌群控制能力的改善。作为一种以“收缩—保持—放松”为基本节律的功能性练习，提肛训练有助于增强个体对局部肌群的感知和调控能力，从而在一定程度上改善排便过程中的肌肉协调。对于部分存在排便行为紊乱或局部控制不足的人群而言，这种训练可能减少排便时反复、低效和无序的努挣，使排便行为趋于更有节律和更低损伤的状态。

进一步看，提肛训练的辅助意义并不在于“直接压制痔体”，而在于其可能通过减少无效用力、降低局部持续高压暴露以及改善排便秩序，间接减轻痔病相关症状。也就是说，其作用路径更接近“功能改善—行为优化—症状缓解”的链条，而非“单纯收缩—直接治痔”的直线因果关系。

2.2 收紧括约肌与减少痔病损伤之间不存在严格意义上的必要联系

本文的核心分析结果是：收紧肛门括约肌与减少痔病损伤之间，并不存在严格医学逻辑上的必要联系。痔病保守管理的基本逻辑在于减少造成局部损伤的根本条件，如缓解便秘、减少排便过度用力、增加膳食纤维和液体摄入、避免长时间蹲厕或坐厕等。也就是说，即使不进行专门的提肛训练，许多患者仍然可能通过改善生活方式和排便习惯而获得症状缓解。

因此，提肛训练不能被界定为痔病损伤减轻的必要前提。其更合理的定位，应是某些情境下可加入的辅助性训练手段，而非不可替代的核心前置条件。

2.3 “暴力美学”式传播叙事强化了对提肛作用的夸大

本文还发现，在大众健康传播中，提肛训练常被赋予一种“越用力越有效”的身体叙事逻辑。这种叙事将自我训练包装为一种可以通过强化收缩来对抗疾病的身体实践，使提肛被想象成一种依靠意志、力量和收紧来实现自我修复的行为。正是在这一意义上，“暴力美学”成为一种对公共话语特征的描述。

然而，这种传播表达会在无形中夸大提肛训练的效能，掩盖其本质上属于功能训练而非治疗操作的事实，并可能诱导部分人形成“只要多夹紧就能防痔”的误解。由此可见，提肛训练在公共叙事中的意义，往往已经超出了其真实的医学适用边界。

3. Discussion / 讨论

3.1 提肛训练的本质应理解为“功能调节”，而非“力量对抗”

本文结果显示，提肛训练真正具有解释力的部分，并不在于其“力量感”，而在于其“控制性”。作为盆底功能训练的一部分，提肛的关键不只是收缩，更包括放松、节律和协调。若仅强调“收紧”，而忽视“收放配合”，则训练就会从功能调节滑向单纯的局部紧张制造。这也是为何大众传播中关于“越用力越有效”的观念值得警惕——它在逻辑上将一种本应细致控制的训练，粗糙地转化为了强度崇拜。

从这一角度看，原标题中的“暴力美学”更适合被视为一种反思性概念。它提示我们，在身体健康话语中，力量和控制常常被过度浪漫化，而真正有效的医疗与康复逻辑，往往并不依赖夸张的身体施压，而依赖更低损伤、更高协调和更稳定的行为秩序。

3.2 痔病管理的核心仍然是对基础危险因素的控制

本文讨论进一步表明，若脱离便秘管理、饮食调整、补液和排便习惯矫正，单独强调提肛训练，很容易造成健康干预重点的错位。痔病的发生和反复，本质上与排便力学和局部压力环境密切相关，真正需要优先处理的，是导致局部高压和持续刺激的基本条件。提肛训练只有在这一总体框架中，才可能发挥辅助意义。

换言之，提肛训练不能替代软便、减压和行为重建。若将其塑造成核心疗法，不仅在理论上站不住脚，也可能在实践中弱化患者对基础生活方式干预的重视。

3.3 该命题更适合作为理论性和健康传播研究议题，而非直接实验化命题

就论文类型而言，本文更接近理论阐释与健康传播分析，而不是严格实验研究。将其转化为“结果—讨论”结构，实际上是把“主要理论发现”显性化，而非声称进行了临床试验。这也说明，该选题的优势在于其交叉性：它既能讨论盆底训练与痔病管理的功能边界，又能分析大众健康叙事如何塑造人们对自我保健行为的理解。

未来若要进一步增强说服力，可在理论基础上引入规范的临床观察或问卷研究，例如比较不同健康传播表述对患者自我管理行为和认知判断的影响。但在当前文本中，更稳妥的定位仍应是理论分析和概念澄清。

4. Conclusions / 结论

本文认为，提肛训练作为一种盆底功能训练方式，确可在一定条件下通过改善局部收缩—放松协调、减少无效努挣和优化排便行为，对痔病症状缓解产生辅助性作用。然而，这种作用主要是间接的、条件性的，并不构

成减少痔病损伤的必要条件。痔病管理的核心仍在于控制便秘、增加膳食纤维和液体摄入、避免排便过度用力以及缩短如厕时间。

从更广义的健康传播角度看，围绕提肛形成的“暴力美学”式叙事，反映了大众对力量、控制和身体规训的偏好，但也容易夸大局部训练的效能。因而，对提肛训练最合理的学术定位，应是将其理解为综合性行为干预中的辅助性工具，而非可被绝对化、神化的独立疗法。本文的意义，在于为这一常见却常被误读的健康命题提供更清晰的概念边界与解释框架。

5. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究性质

本文为理论分析型研究，不涉及临床试验、动物实验或人体干预。研究目的在于对“提肛训练与减少痔病损伤间的必要联系”这一命题进行概念澄清和机制阐释，并结合健康传播语境分析其在公共叙事中的表达偏差。

5.2 分析材料

本文所用材料主要包括以下三类：

（1）围绕提肛训练、盆底肌训练及痔病保守管理形成的基础医学知识框架；

（2）关于痔病发生机制、排便行为与局部压力关系的一般性理论认识；

（3）大众健康传播中关于“提肛防痔”“收紧括约肌减少损伤”等常见话语模式。

上述材料不作为定量统计样本使用，而是作为理论分析与论证的文本基础。

5.3 研究方法

本文主要采用以下方法：

（1）概念分析法。对“提肛”“暴力美学”“必要联系”等核心概念进行界定，避免混淆功能训练、传播修辞与医学逻辑。

（2）机制阐释法。 从盆底功能调节与排便力学角度，对提肛训练可能产生的作用路径进行分析，区分直接效应与间接效应。

（3）规范性论证法。 结合痔病保守管理的一般原则，对“提肛是否构成必要条件”进行逻辑审视。

（4）健康传播分析法。 考察提肛在大众语境中的叙事方式，分析其中对身体力量和控制的审美化表达及其认知影响。

5.4 技术路线

本文首先界定提肛训练的基本内涵及其在公共传播中的修辞化表达；其次分析痔病损伤形成的主要行为学与力学基础；再次讨论提肛训练可能产生的功能性辅助作用；最后对“必要联系”命题进行逻辑辨析，并提出对相关健康传播表达的修正建议。整体研究路径遵循“概念界定—机制分析—命题检验—传播反思”的逻辑顺序。

Acknowledgment / 致谢

在此特别致谢 Deepseek,ChatGPT，豆包，文心一言，通义千问，KiMi，无数个挑灯夜读战的日子，它们随时在线，为我答疑解惑，让我不再独自面对困难。未来我会带着这份感恩继续前行，在学术道路上不断探索，不负众望。

References

[1] Hawkins A T, Davis B R, Bhama A R, et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids[J]. Diseases of the Colon & Rectum, 2024, 67(5): 614-623.
[2] American Society of Colon and Rectal Surgeons. Management of Hemorrhoids (2024)[EB/OL].
[3] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Treatment of Hemorrhoids[EB/OL].
[4] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Hemorrhoids[EB/OL].
[5] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Kegel Exercises[EB/OL].
[6] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Eating, Diet, & Nutrition for Hemorrhoids[EB/OL].
[7] Arnold M J. Management of Hemorrhoids: Guidelines From the ASCRS[J]. American Family Physician, 2025.
[8] MedlinePlus. Kegel exercises - self-care[EB/OL].
[9] Mayo Clinic. Hemorrhoids: Diagnosis and treatment[EB/OL].
[10] Mayo Clinic. Kegel exercises: A how-to guide for women[EB/OL].